

---

# Remuneração como incentivo limitado

Um modelo de escolha racional para o Programa

Mais Médicos Especialistas

---

**Grupo 2** · Bernardo Gomes · Bruno Manta · Felipe Barros · Felipe Marques · Gabriel Benegra · Kauã Santos · Vinicius Sbruzzi

# Sumário

---

## **1 Motivação e Pergunta**

O problema, a política, o índice, os efeitos e a pergunta

---

## **2 Literatura Teórica e Modelo Microeconômico**

De onde vem a equação de escolha, e o que há dentro do custo

---

## **3 Hipótese e Viabilidade Empírica**

O que o modelo implica, o que se testa e o que os dados permitem

---

---

# 1

## Motivação e Pergunta

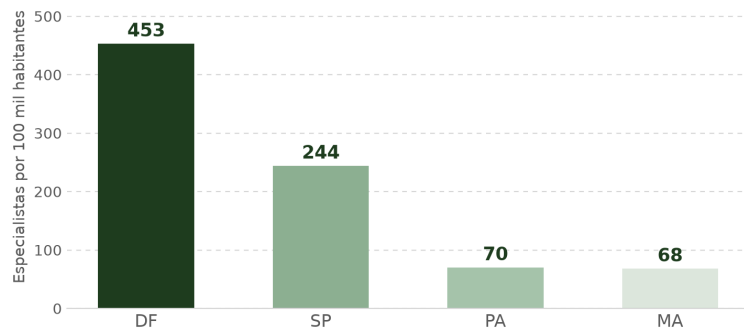
---

O problema, a política, o índice, os efeitos e a pergunta

# O especialista está longe do interior — e quase nunca é só do SUS

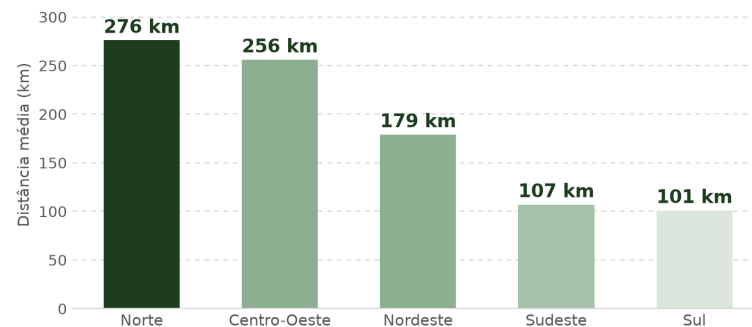
## Onde eles estão

Especialistas por 100 mil habitantes, dez/2024



Dezembro de 2024. As duas maiores e as duas menores razões entre as unidades da federação. Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB).

Distância média para serviços de alta complexidade, em km



Deslocamento para serviços de alta complexidade. Atribuído à REGIC 2018 (IBGE); fonte primária a confirmar.

A escassez é territorial — e onde há menos especialista o paciente anda mais.

# O especialista está longe do interior — e quase nunca é só do SUS

## De quem é o tempo desse especialista

Setor de atuação dos cirurgiões



Cirurgiões, por setor de atuação. Inquérito por amostra do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 1.544 respondentes — não é censo, e não há recorte equivalente para outras especialidades. Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB), cap. 13, Fig. 1, p. 254.

**O SUS não compra a carreira do especialista. Compra uma fração dela** — e disputa o resto com o mercado privado. A bolsa do PMM-E compra **20 horas** dessa fração.

# O especialista está longe do interior — e quase nunca é só do SUS

## E quais especialistas faltam

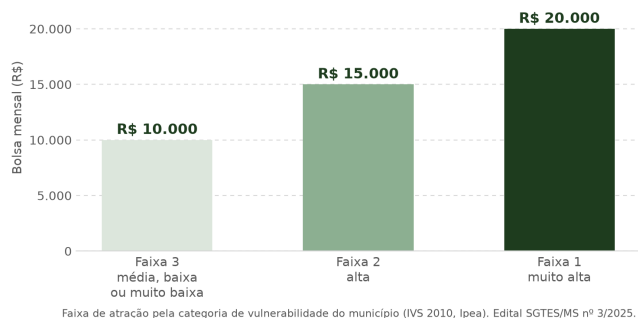
Maiores ofertas do ciclo 1: **endoscopia digestiva alta, colonoscopia e anestesiologia.**

Em 2025 o Ministério declarou **urgência em saúde pública por 24 meses** pelo tempo de espera, e lançou o **Agora Tem Especialistas**, de que o PMM-E é o braço de provimento.

# A bolsa é do município, não do médico nem da especialidade

## O que o programa oferece

Valor mensal da bolsa-formação por faixa de atração



**Lei nº 15.233/2025**, para reduzir o **tempo de espera** do SUS. Bolsa-formação **sem vínculo**, até **12 meses, 20 h semanais, RQE** exigido, com supervisão de instituição formadora — **igual em toda vaga**. O **valor** é a única coisa que varia. Ciclo 1, jul/2025: **1.295 células** estabelecimento-curso em **368 municípios, 678** com vaga imediata.

O programa não forma especialista: exige RQE e compra 20 horas de quem já é.

# A bolsa é do município, não do médico nem da especialidade

## Quem fixa o valor

**Não fixam:** especialidade, curso, estabelecimento, carga, produção, desempenho — nem o médico. **Fixa:** o **município**, e só ele.

| CLÁUSULA | O QUE FIXA O VALOR                                                                                                           | SITUAÇÃO           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11.1.4   | categoria de <b>IVS 2010</b> do Ipea: muito alta → <b>R\$ 20 mil</b> , alta → <b>R\$ 15 mil</b> , demais → <b>R\$ 10 mil</b> | pública            |
| 11.1.3   | "critérios de <i>localização e vulnerabilidade</i> definidos de acordo com a faixa de atração definida no Anexo IV"          | <b>não público</b> |

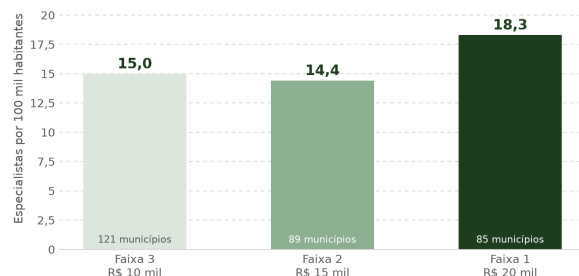
Em **177 dos 368** municípios a faixa publicada está **acima** da categoria de IVS; **zero** abaixo.

O IVS é o piso da bolsa, não o critério dela.

# A bolsa é do município, não do médico nem da especialidade

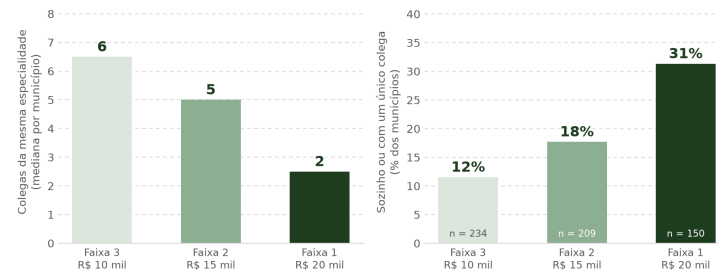
## Para onde a regra manda o dinheiro

### Especialistas por 100 mil habitantes, jun/2025



Junho de 2025, última competência anterior à publicação da oferta. Presença cadastral no CNES nos CBOs dos cursos do programa com correspondência unívoca, nos municípios com vaga no ciclo 1. População residente do Censo 2022.

### Colegas da mesma especialidade no município, jun/2025



Junho de 2025. Especialistas da mesma especialidade cadastrados no município, por par município-especialidade. Faixa 1 tem apenas 19 pares: a proporção é frágil, a mediana é robusta.

**Por habitante**, a bolsa maior não vai para onde falta mais. **Em colegas**, vai: a mediana cai de **6,5** para **2,5**.

A Faixa 1 compensa isolamento, não cobertura.

# Quanto maior o IVS, mais difícil é exercer ali

## O que o índice mede

**IVS 2010, do Ipea** — do *Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros*. Resume **16 indicadores** do **Censo 2010** em um número de **0 a 1**: quanto maior, mais vulnerável. Existe para **todos** os municípios, e é a **parte pública** da regra do valor — a outra, a do Anexo IV, não é.

As categorias do item 11.1.4 são as do próprio Atlas: **muito alta** acima de **0,500**, **alta** entre **0,400** e **0,500**, e **demaís** abaixo disso.

# Quanto maior o IVS, mais difícil é exercer ali

## As três dimensões

| DIMENSÃO              | INDICADORES                                            | O QUE SIGNIFICA PARA QUEM VAI ATENDER ALI              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Infraestrutura urbana | saneamento, coleta de lixo, tempo de deslocamento      | morar e circular custam mais                           |
| Capital humano        | mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescentes | população mais doente, e serviço mais precário         |
| Renda e trabalho      | extrema pobreza, desemprego, informalidade             | quase não há mercado privado para complementar a renda |

As três apontam para o mesmo lado: quanto maior o índice, mais caro é viver ali e mais duro é atender ali.

# O programa já deu sinais; a literatura aponta para os dois lados

---

## O que o ciclo 1 mostra

Preenchimento do ciclo 1, por faixa e por estrato territorial

Das **1.295 células** da primeira chamada, **393 (30,3%)** tiveram alguém confirmado ou homologado.

# O programa já deu sinais; a literatura aponta para os dois lados

## A leitura

### POR FAIXA, NÃO HÁ ORDEM

Pagar o dobro (31,6%) não preencheu mais que pagar uma vez e meia (37,4%).

### POR TERRITÓRIO, HÁ

De **44,9%** no metropolitano a **20,5%** no interior remoto.

**Isto é descrição, não efeito.** As faixas diferem em muito mais que na bolsa, e território prevê melhor que ela. Linguagem correta: **gradiente e associação.**

# O programa já deu sinais; a literatura aponta para os dois lados

## A literatura aponta para os dois lados

### PAGAR MAIS FUNCIONA

**México, salário sorteado.** Em 106 postos, salário **33% maior** elevou a aceitação em **15 p.p.**; a mais de 200 km da cidade natal, de 25% para cerca de **80%**, sem perda de qualificação.

**O degrau tem o tamanho que a literatura pede.** O prêmio exigido para um posto pior vai de **37% a 64%** da renda anual, e a elasticidade da oferta no interior é **0,7**. O degrau do PMM-E é **+50%**.

### PAGAR MAIS NÃO BASTA

**Brasil, o programa-irmão.** No Mais Médicos, **+15,1** médicos do programa por 100 mil viraram **+5,7** de expansão **líquida**. O resto substituiu quem já estava lá.

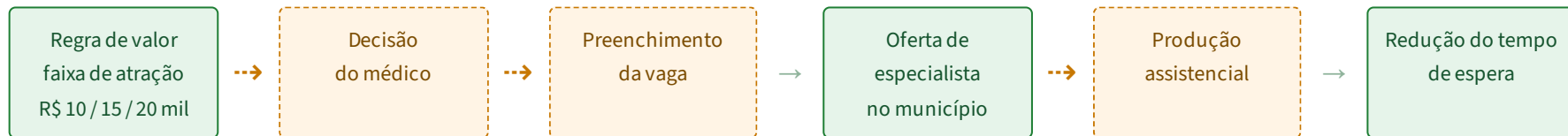
**Austrália, a maioria não vai por preço.** De 3.727 clínicos, **65%** ficaram onde estavam em **todos** os cenários. Para o pior posto, quem mudaria pedia **130%** da renda anual.

**Ressalva:** os percentuais são sobre a **renda total** do médico; a bolsa remunera **20 horas**.

A evidência não decide se um degrau de R\$ 5 mil basta.

# A pergunta que organiza o trabalho

## A cadeia que a política supõe



**Verde e cheia:** está em ato oficial. **Laranja e tracejada:** suposição. Nem o elo cheio seguinte assegura **oferta líquida:** o edital só veda substituição de quem já está lá.

# A pergunta que organiza o trabalho

O incentivo financeiro oferecido pelo PMM-E funciona para atrair especialistas para regiões mais vulneráveis?

Dois objetos, um contra o outro:

## O PREÇO

que a política põs sobre a vulnerabilidade, o **degrau de R\$ 5 mil**.

## A DESVANTAGEM

que esse preço pretende **compensar**.

A margem observada é o **preenchimento da vaga** — o terceiro elo da cadeia, e o primeiro elo suposto é a hipótese do trabalho. Permanência fica fora desta banca.

---

# 2

## Literatura Teórica e Modelo Microeconômico

---

De onde vem a equação de escolha, e o que há  
dentro do custo

# Três tradições sustentam uma equação

| TRABALHO                                                     | ENTRA NO MODELO COMO                                                                                                        | EQUAÇÕES ORIGINAIS                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020), eq. 1, p. 184  | escolha locacional intertemporal: o médico maximiza o valor presente do rendimento real, líquido de um custo não pecuniário | $\arg \max_{i \in I} \left\{ \sum_t \delta^t \left[ \frac{\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})}{p_{it}} - c_{it}^{(s)} \right] \right\}$ |
| Redding & Rossi-Hansberg (2017), eq. 24, p. 28               | equilíbrio espacial: amenidades e custo de moradia determinam a atratividade do lugar                                       | $u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}}$                                                                |
| Choné & Ma (2011), eq. 1, p. 232, com Reinhardt (1972, 1975) | utilidade do médico com altruísmo: atender cansa e satisfaz, e os dois passam por equipe e capital                          | $U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q)$                                                                                           |

Em Redding & Rossi-Hansberg, o numerador é o que **atrai** — salário  $w_i$ , amenidades  $B_n$ , gosto pessoal  $z_{nio}$  — e o denominador é o que **repele**: deslocamento  $\kappa_{ni}$  e moradia  $Q_n$ .

**Atenção ao símbolo  $B$ .** Aqui  $B_n$  é **amenidade** e  $B(q)$  é **benefício ao paciente**. A **bolsa** é  $B_m$ , e só aparece no slide 13.

**FONTES** Moehling et al. (2020), *Cliometrica* 14, p. 184, eq. 1; Redding & Rossi-Hansberg (2017), *Annual Review of Economics* 9, p. 28, eq. 24; Choné & Ma (2011), *Annals of Economics and Statistics* 101/102, p. 232, eq. 1; Reinhardt (1972, 1975); `modelo_micro.md`, §1, §2 e §3.2.

# A escolha locacional maximiza a renda real líquida

## A equação de escolha

O médico  $i$  escolhe o município  $m$  que maximiza o valor presente do rendimento **real**, líquido do custo não pecuniário de viver e atender ali:

$$\arg \max_{m \in M} \left\{ \sum_t \delta^t \left[ \frac{\mathbb{E}(w_{mt}^{(s)})}{p_{mt}} - c_{im}^{(s)} \right] \right\}$$

| TERMO                      | O QUE É                                                         | TERMO          | O QUE É                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| $m \in M$                  | <b>municípios</b> candidatos                                    | $p_{mt}$       | nível de preços local, o deflator                  |
| $\mathbb{E}(w_{mt}^{(s)})$ | remuneração esperada em $m$ , no ano $t$ , na especialidade $s$ | $c_{im}^{(s)}$ | custo <b>não pecuniário</b> de viver e atender ali |
| $\sum_t \delta^t$          | a escolha é de <b>carreira</b> , não de um mês                  |                |                                                    |

# A escolha locacional maximiza a renda real líquida

## Interpretação

Deflaciona a remuneração, subtrai o custo do lugar, desconta a carreira inteira pelo fator  $\delta$  e devolve o município de maior valor.

Salário nominal alto não compensa preços e custos locais altos.

Na equação original  $i$  é a localidade; **daqui em diante  $i$  é o médico e  $m$  é o município**, porque o custo depende de quem escolhe, e não só de onde.

Para os próprios autores,  $c$  reúne "*preferences over rural or urban living ... such as proximity to family*" — uma **caixa-preta**. Os dois slides seguintes a abrem: primeiro o **custo** do lugar, depois a **remuneração** dele.

# O custo da localidade tem duas metades: o lugar e o trabalho

## O lugar

De Redding & Rossi-Hansberg, o custo do **lugar**:

$$c_{im}^{\text{geo}} = \phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}$$

$\phi(\text{dist}_{im})$  é o afastamento da família,  $A_m$  são as amenidades urbanas e  $\theta_i^{\text{rural}}$  é o gosto pessoal por cidade pequena — o único termo sem sinal universal.

# O custo da localidade tem duas metades: o lugar e o trabalho

## O trabalho

De Choné & Ma, com Reinhardt, o custo do **trabalho**:

$$c_{im}^{\text{laboral}} = C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)$$

$C$  é o cansaço de atender  $q$  pacientes,  $B$  é o benefício gerado a eles e  $\alpha_i$  é o altruísmo do médico. Atender cansa de forma crescente ( $C'' > 0$ ) e curar satisfaz de forma decrescente ( $B'' < 0$ ): a curva do custo líquido é um **U** — atender mais compensa até um mínimo, e depois exaure.

**Extensão deste projeto**, motivada por Reinhardt: escrever  $B(q; L, K)$ , e não  $B(q)$  — equipe e capital não só poupam esforço como ampliam o que o atendimento produz.

# O custo da localidade tem duas metades: o lugar e o trabalho

## As três desvantagens, na visão do médico

| DESVANTAGEM        | TERMO               | POR QUE PESA                                                             | MEDIMOS?             |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sem retaguarda     | $L_m$               | não há segunda opinião nem a quem encaminhar: cansa mais e resolve menos | sim, colegas no CNES |
| Sem infraestrutura | $K_m$               | falta leito, insumo e equipamento: o mesmo esforço rende menos saúde     | em parte             |
| Longe da família   | $\phi(\text{dist})$ | cada quilômetro custa, e ninguém paga por ele                            | não                  |

No Brasil, entre 50 mil generalistas formados de 2001 a 2013, **a proximidade do lugar de nascimento ou de formação é o principal fator**; salário e infraestrutura pesam menos.

**Limitação assumida:** CNES e edital não informam a residência do profissional, por sigilo fiscal. A unidade é o **município do estabelecimento**; a distância entra como latente.

# A bolsa é o piso da remuneração, não o total

## A remuneração total

A lei fixa a **bolsa**, não a remuneração. A bolsa compra **20 horas**; o que o médico ganha além delas é mercado local. Por construção, a remuneração é maior ou igual à bolsa:

$$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m) = \underbrace{B_m}_{\text{fixado pela regra}} + \underbrace{w_m^{\text{priv}}}_{\text{mercado local}} \geq B_m, \quad w_m^{\text{priv}} \geq 0$$

|                                    | CAPITAL OU METRÓPOLE                            | INTERIOR ISOLADO                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bolsa</b> $B_m$                 | R\$ 10 mil                                      | R\$ 20 mil                                                                  |
| <b>Mercado</b> $w_m^{\text{priv}}$ | maior                                           | menor — não nulo                                                            |
| <b>Total</b> $w$                   | $\geq$ R\$ 10 mil, e pode passar dos R\$ 20 mil | $\geq$ R\$ 20 mil, e perto do piso                                          |
| <b>Deflator</b> $p_m$              | custo de vida alto                              | supomos menor, e não é garantido: o custo logístico encarece parte da cesta |

# A bolsa é o piso da remuneração, não o total

## Interpretação

A bolsa do interior é o **dobro** da da capital, e ainda assim a **remuneração total** pode ser **menor** lá: o que a regra acrescenta, o mercado local deixa de acrescentar. O deflator puxa no sentido oposto, e não se sabe a priori qual força vence.

Esta é a quarta desvantagem do lugar: onde o mercado privado é fino, a remuneração encosta no piso da bolsa.

Pela dupla prática do slide 4,  $w^{\text{priv}} > 0$  é a regra, não a exceção — o interior isolado tem **menos** mercado, não nenhum.

A política aposta que R\$ 5 mil compensam o lugar. O modelo diz que eles competem com um mercado privado cuja escassez é, ela própria, uma desvantagem do lugar.

---

# 3

## Hipótese e Viabilidade Empírica

---

O que o modelo implica, o que se testa e o que os dados permitem

# No PMM-E, a regra fixa a remuneração e o IVS organiza o custo

## O modelo integrado

$$V_{im} = \sum_t \delta^t \left[ \frac{\mathbb{E}(w_{imt} \mid \mathbf{B}_m)}{p_{mt}} - c_{im} \right]$$

para o médico  $i$  no município  $m$ , com  $\mathbb{E}(w \mid \mathbf{B}_m) = \mathbf{B}_m + \mathbf{w}_m^{\text{priv}}$  do slide 13 e  $c_{im} = c_{im}^{\text{geo}} + c_{im}^{\text{laboral}}$  do slide 12.

| TERMO                        | VARIÁVEL DO PROGRAMA                    | DERIVADA                                                                       | LEITURA                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $\mathbf{B}_m$               | valor da bolsa                          | $\partial V / \partial \mathbf{B}_m > 0$                                       | é o instrumento                         |
| $\mathbf{w}_m^{\text{priv}}$ | mercado local, não observado            | $\partial^2 V / \partial \mathbf{B}_m \partial \mathbf{w}_m^{\text{priv}} < 0$ | a bolsa vale mais onde há menos mercado |
| $p_m$                        | custo de vida, por UF                   | $\partial V / \partial p_m < 0$                                                | opera contra a vulnerabilidade          |
| $c_{im}$                     | <b>IVS</b> e suas dimensões, do slide 6 | $c'_0(\text{IVS}) > 0$                                                         | o custo <b>crece</b> com o índice       |

**O que Moehling, Redding & Rossi-Hansberg e Choné & Ma não têm:** remuneração fixada por **regra pública sobre um índice territorial**. É só isso que a adaptação ao PMM-E acrescenta.

# No PMM-E, a regra fixa a remuneração e o IVS organiza o custo

## A condição de aceitação

Distância, aluguel, mercado local e esforço clínico **não são observados**; o IVS é. O custo do lugar entra por ele, e o que é do médico fica no desvio individual:  $c_{im} = c_0(IVS_m) + \eta_i$ .

O médico  $i$  aceita a vaga em  $m$  quando ela supera sua melhor alternativa  $\bar{v}_i$ :

$$\frac{B_m + w_m^{\text{priv}}}{p_m} - c_0(IVS_m) \geq \bar{v}_i$$

A vaga é preenchida se existir **ao menos um** candidato para quem isso vale. Tudo que aumenta o lado esquerdo aumenta essa probabilidade.

# No PMM-E, a regra fixa a remuneração e o IVS organiza o custo

## Na fronteira entre faixas

**O custo é obstáculo, não hipótese.** Ele não varia livremente: a regra do edital o amarra à bolsa, e os dois sobem juntos. Preencher a vaga do lado mais vulnerável da fronteira exige

$$\frac{\Delta B_m}{p_m} > \Delta c_0, \quad \Delta B_m = \text{R\$ } 5.000$$

A pergunta da apresentação é se essa desigualdade vale.

# Mais remuneração real, mais vagas preenchidas

**H1**

Uma elevação na remuneração oferecida pelo PMM-E eleva a taxa de preenchimento das vagas ofertadas.

$$\frac{\partial \Pr(\text{preenchimento}_m)}{\partial (\mathbf{B}_m/p_m)} > 0$$

A margem é o **preenchimento** da vaga ofertada; permanência está fora desta apresentação.

# Há dado para quase todo termo — e sabemos quais faltam

## O que observamos

| TERMO                                  | O QUE OBSERVAMOS                                                            | FONTE                                  | GRAU     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| <b>Preenchimento</b>                   | confirmação ou homologação por célula estabelecimento–curso, <b>ciclo 1</b> | quadros do edital                      | ● direto |
| <b>Bolsa <math>B_m</math></b>          | faixa anunciada em cada vaga e seu valor                                    | edital e quadro de vagas, ciclos 1 a 3 | ● direto |
| <b>Custo do lugar <math>c_m</math></b> | o <b>IVS 2010</b> , que resume em um número o custo que não se observa      | Ipea                                   | ● proxy  |
| <b>Custo de vida <math>p_m</math></b>  | diferenças entre estados, por efeito fixo de UF                             | IBGE                                   | ● proxy  |
| <b>Equipe <math>L</math></b>           | colegas da especialidade no município, 12 meses prévios                     | CNES mensal                            | ● proxy  |

# Há dado para quase todo termo — e sabemos quais faltam

## O que falta

| TERMO                    | POR QUE NÃO OBSERVAMOS                                      | POR ONDE ENTRA                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mercado local $w^{priv}$ | RAIS nunca adquirida; CNES não traz renda nem carga horária | IVS, dimensão de renda e trabalho                  |
| Custo de moradia         | sem fonte municipal no repositório                          | IVS, dimensão de infraestrutura urbana             |
| Capital $K$ e volume $q$ | competências do CNES físico não baixadas; SIH bloqueado     | IVS, dimensões de infraestrutura e capital humano  |
| Distância da família     | residência do profissional é sigilo fiscal                  | não é do lugar: fica no desvio individual $\eta_i$ |

**Sim, para o essencial:** desfecho e instrumento são diretos, e o custo do lugar entra inteiro pelo **IVS** — quanto maior o índice, maior o custo.

O IVS é a proxy declarada do que não se mede. Isso é uma escolha, não uma solução.

---

# Perguntas

---

O material de apoio está no apêndice, a seguir

# Por que o desafio metodológico não está na apresentação

---

## A regra existe e é determinística

Na janela estável de fev a ago/2026, o rótulo administrativo de IVS determina a faixa de bolsa em **527 de 527** municípios, sem uma única ambiguidade.

O que não se recupera é o **escore**. A regra de facto não é a publicada: em oito das nove competências, muito alta e alta vão para a **Faixa 1**, média para a **Faixa 2**, baixa e muito baixa para a **Faixa 3**. Só jan/2026 segue o texto do FAQ.

O problema nunca foi a regra não existir. É que o escore que a alimenta não é o IVS 2010 público.

# Por que o desafio metodológico não está na apresentação

## Nenhum corte sobre o IVS público reproduz a atribuição

| REGRA TESTADA SOBRE O IVS 2010 PÚBLICO                      | ACERTO                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cortes do Ipea supostos, 0,400 e 0,500                      | 191 de 368 — <b>51,9%</b> |
| Melhor par de cortes, por busca exaustiva, em 0,323 e 0,377 | 285 de 368 — <b>77,4%</b> |

Em 44.073 pares comparáveis há **2.763 inversões (6,3%)**: municípios com IVS *maior* que recebem bolsa *menor*. Uma inversão já basta para provar que nenhuma regra monótona de limiar reproduz o anúncio, qualquer que seja o corte.

# Por que o desafio metodológico não está na apresentação

## Nos dois cortes, não há o que saltar

### EM 0,500 NÃO HÁ O QUE SALTAR

Na janela de  $\pm 0,050$  há 31 municípios e **todos são Faixa 1**, dos dois lados.

### EM 0,400 NÃO HÁ FAIXA 3 POR PERTO

O maior IVS da Faixa 3 é **0,372**.

Onde a bolsa de fato varia, a variação é governada pelo critério de localização, que não observamos.

# Por que o desafio metodológico não está na apresentação

## E a variação que sobra não é ruído

Dos 83 municípios fora da melhor regra, os **41** que recebem mais do que o IVS preveria têm mediana de população de **7.933** contra **32.179** dos **42** que recebem menos, e **12 de 41** estão em interior remoto contra **2 de 42**.

O tratamento é localmente constante nos dois cortes, e o que sobra está alinhado com remotividade — o previsor mais forte do próprio desfecho.

**O que destrava:** um único campo, o **escore administrativo de IVS por município**, com safra, precisão e arredondamento. Com ele o primeiro estágio é *sharp* por construção, porque a categoria já determina a faixa em 527/527.

# A literatura que ficou de reserva

Os dois trabalhos que saíram da tabela do slide 7 quando ela foi reduzida a dois de cada lado. Ambos continuam registrados no repositório.

| TRABALHO                                                          | O QUE MEDE                                                                                          | O QUE ENCONTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Costa, Nunes &amp; Sanches (2024), <i>REStat</i> 106(1)</b>    | escolha locacional de generalistas formados no Brasil, escolha discreta com coeficientes aleatórios | elevar em <b>50%</b> o salário público no interior do Norte e Nordeste corrige <b>12,4%</b> do desequilíbrio geográfico, a <b>US\$ 15,7 milhões</b> por ponto percentual. Cotas em escolas médicas para nascidos em áreas desassistidas corrigem <b>63,8%</b> , a <b>US\$ 2,2 a 5,1 milhões</b> por ponto |
| <b>Pathman, Konrad &amp; Ricketts (1992), <i>JAMA</i> 268(12)</b> | coorte de nove anos, 412 médicos nos Estados Unidos                                                 | oito anos depois, <b>12%</b> dos que foram com bolsa e <b>obrigação de serviço</b> seguiam na prática original, contra <b>39%</b> dos que foram <b>sem</b> obrigação                                                                                                                                      |

**Um mede o preço de mover; o outro, o preço de fazer ficar.** Nenhum dos dois foi para a tela, e os dois respondem perguntas prováveis.

Os próprios autores do primeiro escrevem que *"as baixas elasticidades-salário podem explicar por que incentivos financeiros no Brasil não foram suficientes para atrair mais médicos para áreas desassistidas"*.

# Duas notas sobre a regra que não vão à tela

| NOTA                        | O QUE DIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ONDE ESTÁ                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Contribuição previdenciária | o participante é segurado obrigatório do RGPS, como <b>contribuinte individual</b> , e o valor devido é <b>descontado da bolsa-formação</b>                                                                                                                                                                                  | Edital SGTES/MS nº 3/2025, <b>item 11.2</b> |
| Adicional territorial       | a Lei prevê acréscimo para <b>Amazônia Legal</b> , territórios indígenas e áreas de alta vulnerabilidade, " <i>conforme regulamentação do Ministério da Saúde e disponibilidade orçamentária</i> ". <b>Não foi regulamentado no ciclo 1:</b> a palavra "adicional" aparece uma única vez no edital, e no barema de titulação | Lei nº 15.233/2025, <b>art. 22-D, §4º</b>   |

Nenhuma das duas vira afirmação sobre o tamanho líquido do degrau de R\$ 5 mil: isso depende do teto de contribuição, e não foi calculado.

É essa a razão de estarem aqui e não no slide 5. O degrau que a apresentação discute é o **anunciado**, bruto, que é o que a regra fixa e o que o candidato lê no quadro de vagas.

# O que ainda não fechamos

As pendências abertas, com o efeito de cada uma sobre o que foi dito.

| # | PENDÊNCIA                                                                                                               | EFEITO SOBRE A TELA                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | a figura por UF é dos <b>quatro</b> valores com fonte registrada, não das 27 unidades                                   | a tela perde o panorama completo por UF                                             |
| 2 | os valores de deslocamento não tiveram a <b>fonte primária confirmada</b>                                               | número em tela atribuído à REGIC 2018, a confirmar                                  |
| 5 | "Sudeste 55,4% dos especialistas" está conferido em cobertura, não localizado no PDF                                    | ressalva de fonte; fora da tela                                                     |
| 8 | a retaguarda é medida no <b>município</b> , mas 42,6% das células estão em estabelecimento de gestão estadual           | ou o slide 5 ganha uma linha de limitação, ou o descasamento vira argumento próprio |
| 9 | os slides 6, 15 e 17 dizem que o <b>custo cresce com o IVS</b> ; o documento canônico trata o sinal como <b>ambíguo</b> | divergência declarada entre a tela e a teoria do projeto, por decisão do autor      |

Nenhuma delas muda a pergunta nem a hipótese. Todas são de rastreio ou de simplificação declarada.